45. Deutscher Koloproktologen Kongress



Vortrag: Abgabe-Erwerb Kassenzulassung - Vorgehensweise und aktuelle Entwicklungen

Autor(en): S. Haniffa, München [6]

Offenlegung finanzieller Interessen:

[1]: Berater (B):	Kommerzielle Vergütung oder Unterstützung des Autors in den letzten drei Jahren in Form von Beraterverträgen (Mitgliedschaft in Gremien, Beiräten, Aufsichtsräten etc.)
[2]: Eigentümer (E):	Eigentümerinteresse an Arzneimittel/Medizinprodukten (z.B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz, etc.)
[3]: Investor (I):	Finanzielles Interesse an Firmen, die eine beschriebene Ausrüstung, ein Verfahren oder Produkte liefern (z.B. Aktienbesitz, Anteilseigner etc.)
[4]: Mitarbeiter (M):	Finanzielles Interesse bei der Produktvermarktung (Mitarbeiter des Produktherstellers)
[5]: Produkt (P):	Finanzielles Interesse bei der Ausrüstung, dem beschriebenen Verfahren und/oder dem beschriebenen Produkt (z.B. Forschungsunterstützungen, Referentenhonorare, Reisekostenunterstützungen, Stipendien etc.)
[6]: Keine (K):	Keine Interessenskonflikte; keine kommerzielle Unterstützung der vorgelegten Arbeit in irgendeiner Form

Abgabe / Erwerb einer Kassenzulassung

KVB
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns

Stephan Haniffa, Teamleiter Präsenzberatung Süd

München, 16.03.2019



Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB)



- Servicepartner und Dienstleister für Vertragsärzte, Vertragspsychotherapeuten und Patienten Bayern
- größte Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands mit ca. 28.000 Mitgliedern
- betreut ihre Mitglieder mit ca. 1.650 Beschäftigten serviceorientiert und zuverlässig
- verteilt Honorar für ihre Mitglieder in Höhe von ca. 5,5 Mrd. Euro
- Mitglieder sichern die ambulante ärztliche Versorgung von rd. 11 Mio. GKV-Versicherten im Freistaat

Bedarfsplanung: Versorgungsebenen seit 01.01.2013

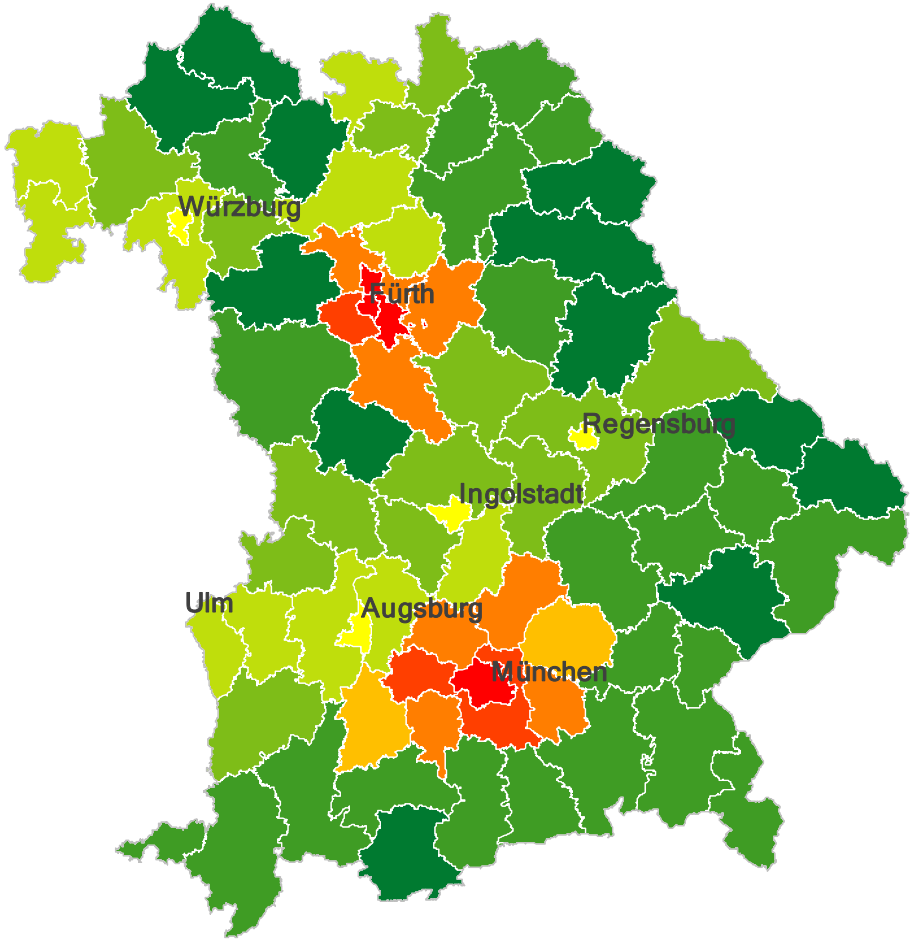
KVB Kassenärztliche Vereinigung Bayerns

Hausärztliche Versorgung	Fachärztliche Versorgung		
	Allgemeine Fachärztliche Versorgung	Spezialisierte Fachärztliche Versorgung	Gesonderte Fachärztliche Versorgung
Mittel-bereiche *)	**Kreise** (kreisfreie Städte, Land-kreise, Kreisregionen) (**5 Kreistypen**)	**Raumordnungs-regionen**	**KV-Bezirk**
Allgemeinärzte **Praktische Ärzte** **Hausärztliche Internisten**	**Augenärzte** **Chirurgen** **Frauenärzte** **HNO-Ärzte** **Hautärzte** **Nervenärzte** **Orthopäden** **Urologen** **Psychotherapeuten** **Kinderärzte**	**Anästhesisten** **Radiologen** **Fachinternisten** **Kinder- und Jugendpsychiater**	**Physikalische und Reha-Mediziner** **Nuklearmediziner** **Strahlentherapeuten** **Neurochirurgen** **Humangenetiker** **Laborärzte** **Pathologen** **Transfusionsmediziner**

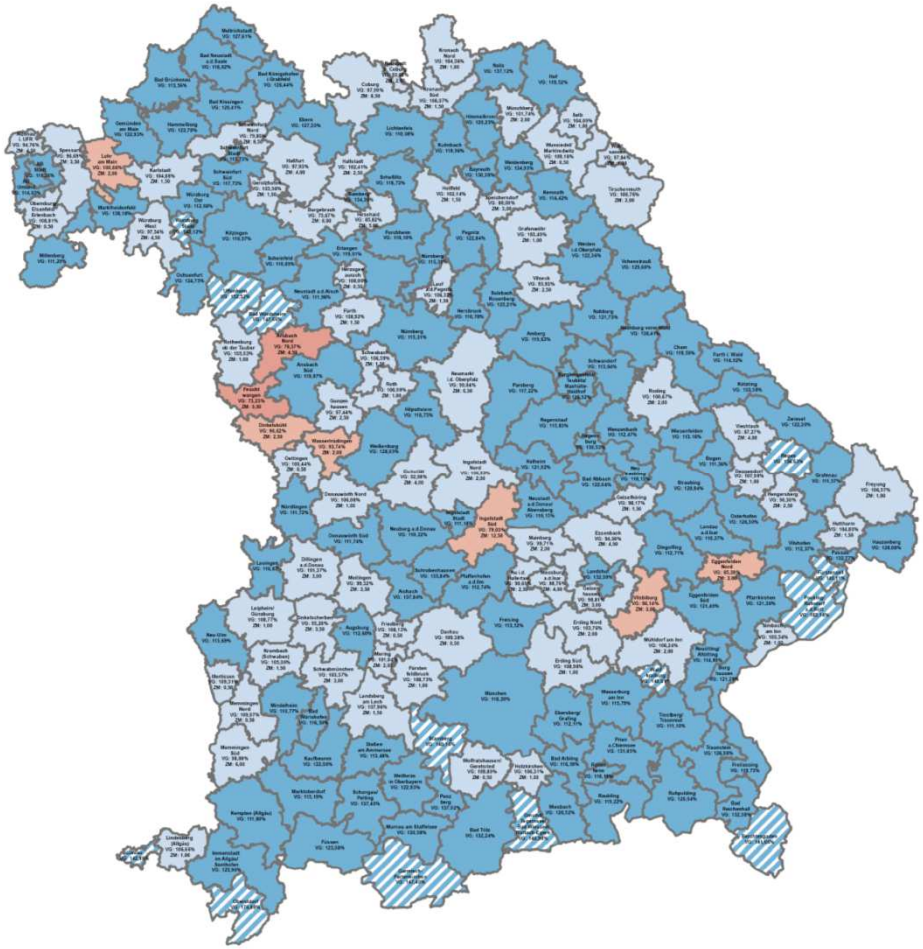
*) **zum Teil weiter aufgespalten!**

Bedarfsplanung: Planungsbereiche neu - hausärztliche Versorgung

79 Stadt-/Landkreise, Kreisregionen

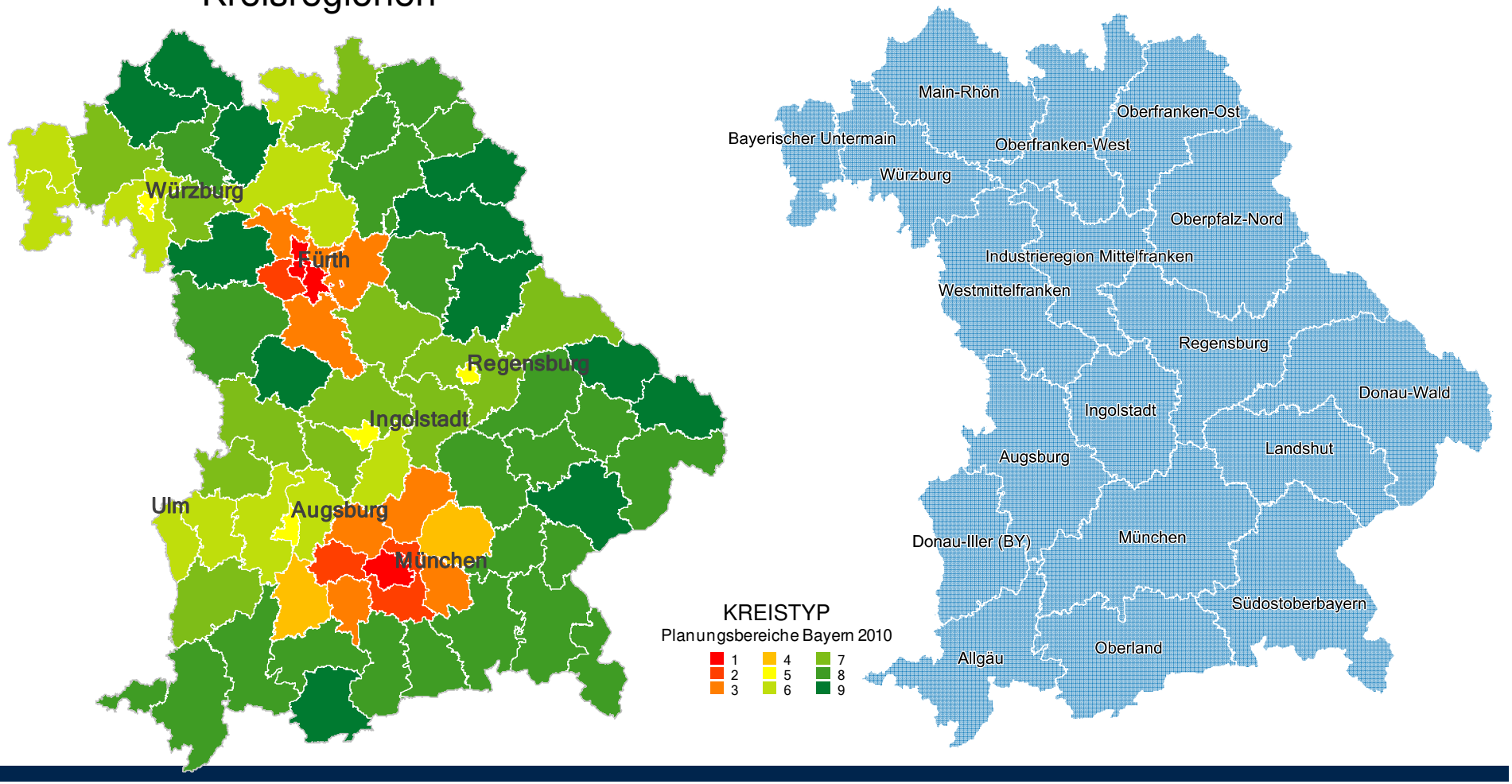


über 200 Mittelbereiche



Bedarfsplanung: Planungsbereiche neu - spezialisierte fachärztliche Versorgung

79 Stadt-/Landkreise, Kreisregionen → 18 Raumordnungsregionen



Zulassungsrechtliche Rahmenbedingungen

2-stufiges Antragsverfahren für Systemzugang

Approbation

+

Facharzt-anerkennung

Antrag

Arztregister



KV des Wohnorts

Antrag

Zulassung, Anstellung, Ermächtigung



Foto: iStockphoto.com

Zulassungsausschuss des Praxissitzes

notwendig für:
- **alle Formen der Zulassung**
- **alle Formen der Anstellung nach SGB V**

notwendig für:
- **alle Formen der Zulassung**
- **alle Formen der Anstellung nach SGB V**
- **Ermächtigung**

Teilnahmeformen

Assistenz
- Weiterbildungsassistent
- Sicherstellungsassistent

Anstellung
- ¼, ½, ¾, Vollzeit
- bei einem Vertragsarzt
- im MVZ
- „Jobsharing-Anstellung“

Zulassung
- volle Zulassung
- halbe Zulassung
- Jobsharing - Zulassung

Ermächtigung

Vertretung

Praxisabgabesituationen

Typische Abgabesituationen

- Verzicht auf die Zulassung
- Verlegung / Wegzug
- Tod
- Reduzierung des eigenen Versorgungsauftrags auf die Hälfte + „Teilausschreibung“



Foto: Getty Images

Möglichkeiten der Praxisabgabe

Verkauf der Praxis an einen neu zuzulassenden Arzt

Verkauf der Praxis an einen Job-Sharing Partner

Einstellung der Tätigkeit ohne Nachfolger



Foto: Getty Images

Verkauf der Praxis an ein Medizinisches Versorgungszentrum

Abgabe der Praxis an einen Kollegen und Weiterarbeit als Angestellter

Fusion mit einem Vertragsarzt zum Zwecke der Weiterverwertung des Sitzes durch Hereinnahme eines Partners

Verlegung der Praxis in ein medizinisches Versorgungs-zentrum und Weiterarbeit als Angestellter

Praxisübergabekonstellationen I

- Praxisübergabe im ungesperrten Bereich

- Praxisübergabe im nicht-beplanten Fachgebiet
  (derzeit nur mehr MKG-Chirurgen)

- Praxisübergabe im gesperrten Bereich (bis 140% <-> ab 140%?)
  - Einzelpraxis / Praxisgemeinschaft
  - Berufsausübungsgemeinschaft / privilegierter Übernehmer

- Praxisübergabe an ein Medizinisches Versorgungszentrum bzw. an einen zugelassenen Kollegen in Verbindung mit einer Anstellung

Praxisübergabekonstellationen II



Die meisten Planungsbereiche sind für die meisten Fachgebiete gesperrt. Bei der Planung der Praxisübergabe ist es wichtig zu wissen, ob der Planungsbereich für das Fachgebiet gesperrt ist!

falls Planungsbereich gesperrt:

Nachbesetzungs-Antragsverfahren vor dem ZA gem. § 103 Abs. 3a SGB V:
Prüfung der Versorgungsrelevanz des nach zu besetzenden Sitzes erforderlich*)

Versorgungsrelevanz gegeben:

- gesetzlich vorgeschriebenes öffentliches Ausschreibungsverfahren durch die KV;
  –> kein zusätzlicher Ausschreibungsantrag notwendig
- falls dabei mehrere Bewerber auftreten: Auswahlverfahren durch den ZA gem. § 103 Abs. 4 SGB V

Versorgungsrelevanz nicht gegeben:

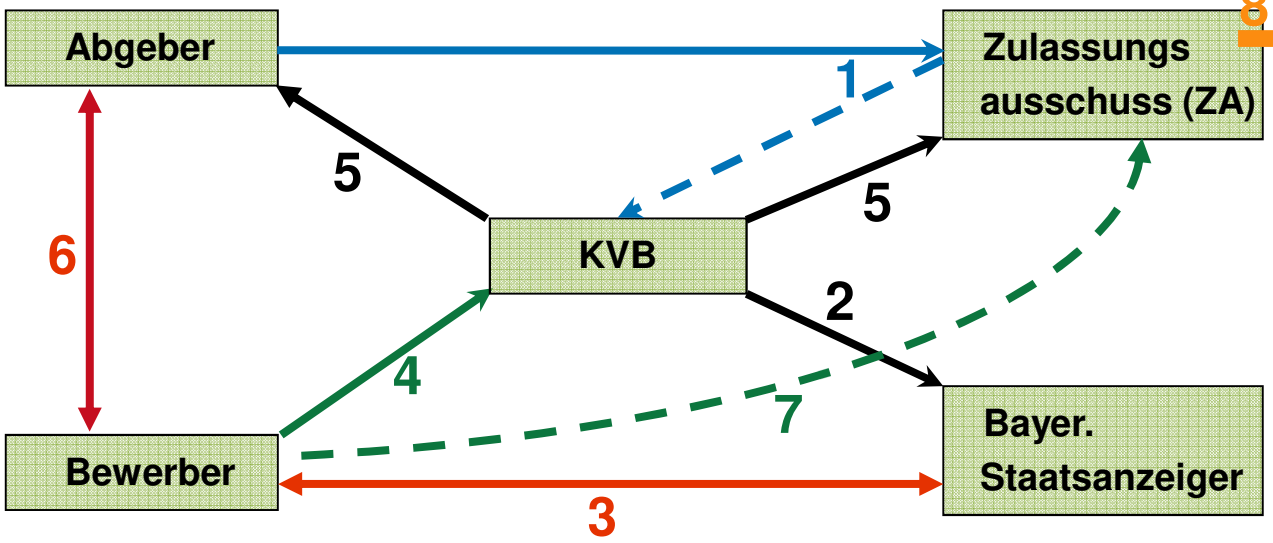
- bis 140% Versorgungsgrad: ZA **kann** die Nachbesetzung ablehnen
- ab 140% Versorgungsgrad: ZA **soll** die Nachbesetzung ablehnen
- Ausnahmen: Nachfolger gehört zu privilegiertem Personenkreis
  - bei mind. 5 Jahren v.ä. Tätigkeit in einem unterversorgten Gebiet (wenn nach dem 23.07.2015 erstmalig aufgenommen)
  - wenn Ehegatte, Lebenspartner oder Kind des bisherigen VA
  - wenn angestellter Arzt des bisherigen VA oder BAG-Partner der Praxis (bei Begründung ab dem 05.03.2015 jeweils mind. 3 Jahre lang)
  - bei Verpflichtung zur Verlegung in ein anderes Gebiet des PB mit Versorgungsbedarf aufgrund einer zu geringen Ärztedichte
- bei Ablehnung der Nachbesetzung ggf. Entschädigung durch KV in Höhe des Praxisverkehrswertes
- Privilegierungs- und Entschädigungsregelungen gelten nicht bei Sonderbedarfs-Nachbesetzung

*) Nicht bei Umwandlung einer Anstellung in eine Zulassung i.V.m. einer Ausschreibung gemäß § 95 Abs. 9b S. 1/2. Hs. SGB V

Fotos: Getty Images

Ausschreibung und Bewerberauswahl I

Nachbesetzungs-/Ausschreibungsverfahren + Bewerberauswahl



Bewerberauswahlverfahren § 103(4) SGB V:

- berufliche Eignung
- Approbationsalter
- Dauer ärztl./psychotherapeut. Tätigkeit **)
- mind. 5 J. Tätigkeit in unterversorgtem Gebiet
- Bewerber ist Ehegatte, Partner oder Kind des bisherigen VA
- Bewerber ist angestellter Arzt des bisherigen VA oder BAG-Partner der Praxis
- Bewerber ist bereit, definierte besondere Versorgungsbedürfnisse zu erfüllen
- Belange von Behinderten beim Zugang zur Versorgung
- ggf. Ergänzung des besonderen Versorgungs-angebotes eines MVZ
- Dauer der Eintragung in Warteliste

1	seit 2013: Antrag auf Durchführung eines Nachbesetzungs-/Ausschreibungsverfahrens an den ZA/(ggf. weiter an KVB)	5	Info über Bewerber von KVB an Abgeber und ZA
2	ggf. dann öffentliche Ausschreibung durch KVB im Bayer. Staatsanzeiger	6	Privat-Verhandlungen zwischen Abgeber und Übernehmer (z.B. Kaufpreis, Vertrag)
3	Kenntnisnahme der Ausschreibung im Bayer. Staatsanzeiger durch Bewerber	7	Zulassungsantrag des Bewerbers an den ZA
4	(formlose) Bewerbung auf die Ausschreibung an KVB durch Bewerber *)	8	Bewerberauswahlverahren beim ZA gem. § 103 Abs. 4 SGB V

*) Alternativ: formgebundener Zulassungsantrag an die Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses. Die Einreichung eines formgebundenen Zulassungs-antrags an die Geschäftsstelle des Zulassungsausschusses ist in jedem Falle – auch bei vorheriger formloser Ausschreibungsbewerbung – notwendig.

) Wird ggf. verlängert um Zeiten der Unterbrechung der ärztl. Tätigkeit wg. **Kindererziehung oder **Pflege naher Angehöriger in häuslicher Umgebung!**

Vorgehen bei der Praxisübergabe

- Markterkundung / Bedarfssituation
  - Wertvorstellung
    - Favoriten suchen, ggf. unter Einschalten Dritter
      - Mit Favoriten im Grundsatz einigen
        - Favoriten qualifizieren
          - Nachbesetzung/Ausschreibung beantragen
            - Zulassungsausschuss überzeugen
              - Vertrag schließen
                - Übergabe Patienten; ggf. Kollegen vermitteln
                  - Veräußerungsgewinn optimal verwenden
                    - Lebenswerk vollenden

Zeitschiene Praxisabgabe

Langfristige Planung

- **> 2 Jahre:** mit Steuerberater Abgabeplan erörtern; Einkommenssituation analysieren; Beginn mit der Nachfolgersuche
- **1 - 2 Jahre:** Unterlagen mit Praxisdaten aufbereiten, evtl. Praxiswertgutachten erstellen lassen

Mittelfristige Planung

- **½ - 1 Jahr:** (Vor-)Vertragsgestaltung, Wunschnachfolger auswählen

Kurzfristige Planung

- **6 Monate:** Mitteilung an KV/Zulassungsausschuss Information der Angestellten, ggf. Einarbeitung des Praxisnachfolgers (sog. Schnupperassistent)

Seit 01.01.2013:
vorgeschaltetes Nachbesetzungsprüfungsverfahren beim ZA gemäß § 103 Abs. 3a SGB V bei der Zeitplanung zu berücksichtigen!



Gutes Zeitmanagement ist die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen der Praxisabgabe!

Foto: Getty Images

Nachfolgersuche II

Wie finde ich einen Praxisübernehmer?



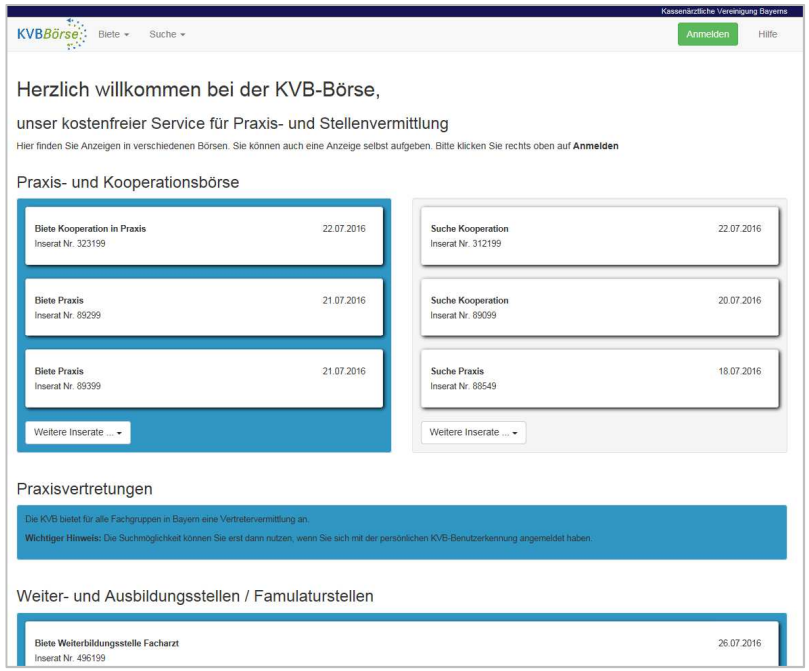
Foto: Getty Images



Foto: Jupiter Images Corporation

- kostenfreie KVB-Börse bzw. Anfrage bei KVB
- sonstige überregionale Anbieter von (Internet-)Praxisbörsen
- private Vermittler/Berater
- Deutsches Ärzteblatt / sonstige Fachzeitschriften
- Informationen aus dem Kollegenkreis
- Pharmareferenten

KVB-Börse - Praxisbörse



- ein kostenfreier Service der KVB
- diskret, vertraulich, neutral (bei uns sind keine Vermittlungsverträge notwendig oder Werbeattacken zu befürchten)
- Praxissuchende und Praxisabgeber erfassen ihre Anzeige in der KVB-Börse
  – Mit Kontaktdaten oder auf Wunsch als Chiffre-Anzeige
- Aktualisierung des Inserates jederzeit möglich
- Komfortable Suchmöglichkeiten
- Auch auf Tablet oder Smartphone nutzbar
- Aktualisierungsabfrage nach 5 Monaten

Die KVB-Börse finden Sie unter **www.kvb.de** in der Registerkarte *Online-Zugänge*

Verhandlungsstrategie I

Mögliche Argumente des Praxisübernehmers

- keine Einflussnahme auf Standort, der auch gar nicht erste Wahl ist
- eingefahrene Organisation und Betriebsblindheit des zu übernehmenden Personals
- hoher Reorganisations- und hoher Investitionsbedarf
- Raumkonzept nicht mehr zeitgemäß
- überalterte Patientenstruktur
- kein marktgerechtes Preis- / Leistungsverhältnis

Verhandlungsstrategie II

Wichtige Argumente des Praxisabgebers

- Marktenge
- kürzere Anlaufzeit
- funktionsfähige Organisation
- eingearbeitetes, engagiertes Personal
- dem Patienten vertrautes Leistungsspektrum
- eingeführter Standort
- gewachsene Kooperationen und Kollegenbeziehungen
- Finanzierung leichter darstellbar

Basisdaten

Wichtige Basisdaten

- ✓ KVB-Quartalsauswertungen
- ✓ Umsatz : Kasse, Privat, Gutachten, Sonstiges
- ✓ Fallzahl und Fallwert
- ✓ Betriebsausgaben
- ✓ Arbeitsstunden
- ✓ Schulden und Vermögenswerte
- ✓ Versicherungsbestand
- ✓ Umsatzrendite
- ✓ Personalkostenquote
- ✓ Miete und Laufzeit
- ✓ Abschreibungsvolumen
- ✓ Konditionen und Laufzeiten für noch laufende Finanzierungen



Die Kenntnis dieser Daten ist Voraussetzung für gezielte Abgabegespräche!

Foto: Getty Images

Gestaltung des Praxisübergabevertrages

Checkliste Praxisabgabevertrag

- Form des Vertrages
- Parteien des Vertrages
- Übergabedatum
- Inventarverzeichnis
- Mietvertrag
- Mitarbeiter / Arbeitsverträge
- Übrige Verträge
- Patientenkartei
- Kaufpreis
- Wirtschaftliche Kennziffern
- Mängelhaftung
- Althonorare
- Kaufpreiszahlung
- Kaufpreissicherung
- Haftung des Erwerbers
- Konkurrenzklausel
- Schiedsgerichtsabrede/ Schlichtungsklausel
- Unterschrift des Ehegatten
- Salvatorische Klausel
- Kostentragung

Praxiswert I

Praxiswert	=	materieller Wert (Substanzwert)	+	immaterieller Wert (ideeller Wert, Goodwill)



Foto: Getty Images

Praxiswert ≠ Verkaufspreis (ergibt sich aus Angebot und Nachfrage!)



Foto: BilderBox.com

Gutachten zur Feststellung des Praxiswertes:

- sinnvoll zur eigenen Sicherheit
- für den Zulassungsausschuss dann notwendig,
  wenn ein geeigneter Bewerber behauptet, dass Konkurrenten bevorzugt werden,
  weil sie einen höheren Preis zu zahlen bereit sind

Praxiswert II

Faktoren, die den Wert einer Praxis beeinflussen:

- Geräteausstattung, Einrichtung

→ Substanzwert

- Patientenstamm
- Bekanntheitsgrad der Praxis
- Umsatz der Praxis
- Lage der Praxis
- Bedarfssituation
- Ertrags-/ Kostensituation
- Zukunftsperspektive

→ Ideeller Wert/ Goodwill

(= Preis für die Aufbau- und Organisations-leistung des Vorgängers)

Praxiswert III

Wer stellt den Wert einer Praxis fest?

- Sachverständige (öffentlich bestellte und vereidigte) ☺
- Wirtschaftsprüfer ☺
- Berater von in der Finanzierung von Praxisübernahmen breit engagierten Banken ☺
- selbst ernannte Experten ☹



KVB-Berater können unterstützend beraten!

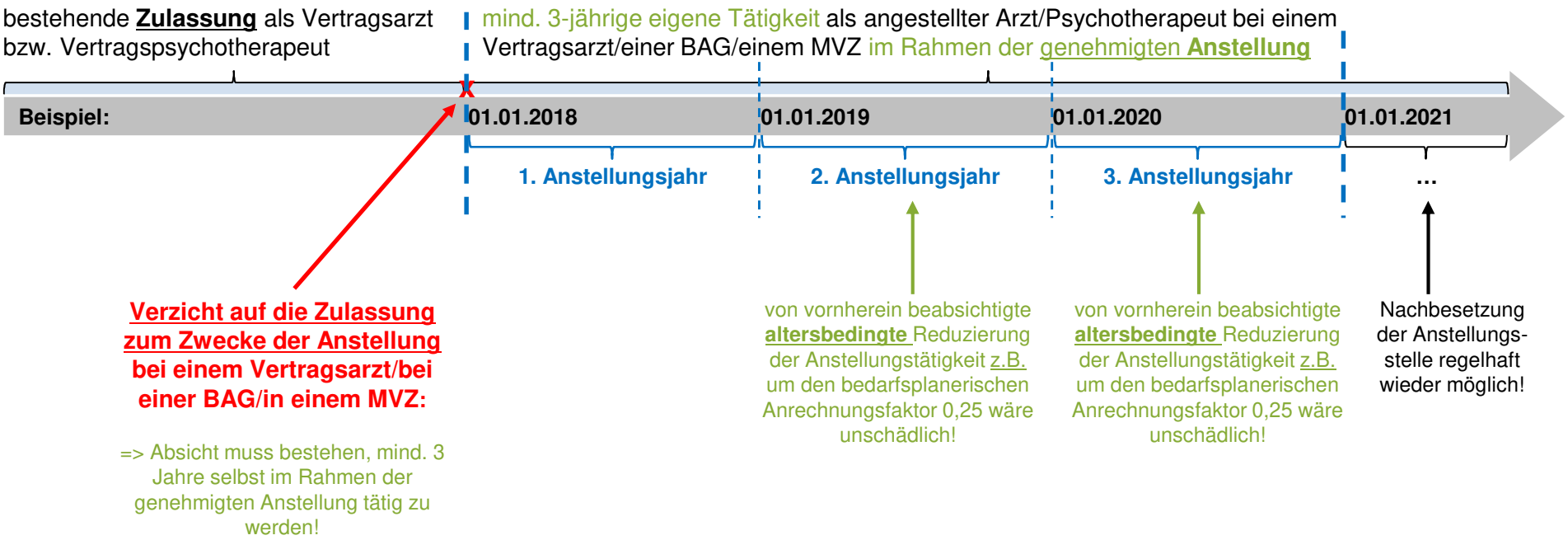
Was ist die richtige Bewertungsmethode?

Es gibt keine gesetzliche Vorgabe und keine allgemein-verbindliche Methode zur Ermittlung des Wertes einer Arztpraxis. Im allgemeinen kommen aber zukunfts- bzw. ertragswertorientierte Methoden zum Einsatz. Die Standesorganisationen BÄK und KBV haben hierzu „*Hinweise zur Bewertung von Arztpraxen*“ herausgegeben.

Foto: Getty Images

Verzicht auf die Zulassung zum Zwecke der Anstellung I

„3-Jahres-Urteil“ des BSG vom 04.05.2016 - B 6 KA 21/15 R



Gestaltungsoption: Teilzulassung

„Teilzulassung“:

- ➡ Zulassung mit **hälftigem Versorgungsauftrag**
- ➡ Anrechnung in der Bedarfsplanung mit Faktor 0,5
- ➡ Mindestsprechstundenangebot am VA-Sitz von 10 Std./Wo.
- ➡ Nebentätigkeit in Beschäftigungsverhältnis regelhaft bis 26 Std./Wo.

durch Erklärung der „Reduzierung des Versorgungsauftrages auf die Hälfte“ gegenüber dem Zulassungsausschuss!

„Teilzulassung“ durch hälftigen Verzicht bei einer bestehenden Vollzulassung

ggf. Ausschreibung und Nachbesetzung/
Übergabe der reduzierten Hälfte möglich!

originäre
„Teil-Neuzulassung“

- ➢ **bei hälftigem Verzicht bei einer bestehenden Zulassung:**
  - im gesperrten Planungsbereich Ausschreibung des reduzierten Teils der Zulassung möglich, aber ausschreibungsfähiges Praxissubstrat (wird geprüft) muss bestehen!
  - Rückführung in „Vollzulassung“ nur wenn keine Zulassungsbeschränkung besteht
- ➢ 2 Teilzulassungen möglich, auch fachgebiets-/versorgungsbereichsübergreifend bzw. KV-übergreifend

Teilnahmeformen

Sonderform Job-Sharing: **Zulassung/BAG-Bildung** oder **Anstellung**

- Möglichkeit zur **Teilzeit-Tätigkeit**
- Für jeden in der Bedarfsplanung angerechneten Arzt (Ausnahme „Sonderbedarf“) kann grds. **1 weiterer Arzt** im Rahmen des JS zugelassen oder angestellt werden**;** dabei **feste 1:1-Zuordnung** von Senior und Junior!
- **Fachidentität gem. § 41 BeplaRili** zwischen „Senior-“ und „Juniorpartner“ erforderlich
- **Beschränkung der abrechenbaren Leistungsmenge** auf (im wesentlichen) den bisherigen Praxisumfang! (Sonderregelung bei bisher unterdurchschnittlichem Praxisumfang)

Zulassung im Rahmen des Job-Sharing + BAG-Bildung	**Anstellung im Rahmen des Job-Sharing**
■ im gesperrten Planungsbereich ■ BAG-Gründung; Vertragsarztstatus d. Juniors ■ Zulassung Junior, aber vinkuliert m. der Zulassung des Seniors und dem GP-Bestand ■ nach 10 Jahren Vollzulassung, evtl. bereits vorher bei Entsperrung; nach 3 Jahren ggf. Berücksichtigung bei Praxisnachbesetzung möglich ■ Junior kann neues Leistungsspektrum einbringen	■ im gesperrten Planungsbereich ■ kein Vertragsarztstatus des Juniors ■ Junior ist Angestellter mit Arbeitsvertrag; ärztliche Tätigkeit wird dem Senior zugerechnet ■ bei Entsperrung evtl. Überführung in „normales“ Angestelltenverhältnis; nach 3 Jahren ggf. Berücksichtigung bei Praxisnachbesetzung möglich ■ Junior kann neues Leistungsspektrum einbringen ■ ggf. Ausnahmen von der Leistungsbeschränkung bei zusätzlichem lokalem Versorgungsbedarf

Sinnvolle JS-Situationen: Krankheit, Familie, Übergang, Teilzeit, Ausbau Selbstzahlerpraxis

Foto: Getty Images

Praxisabgabe an ein MVZ I

Medizinisches Versorgungszentrum

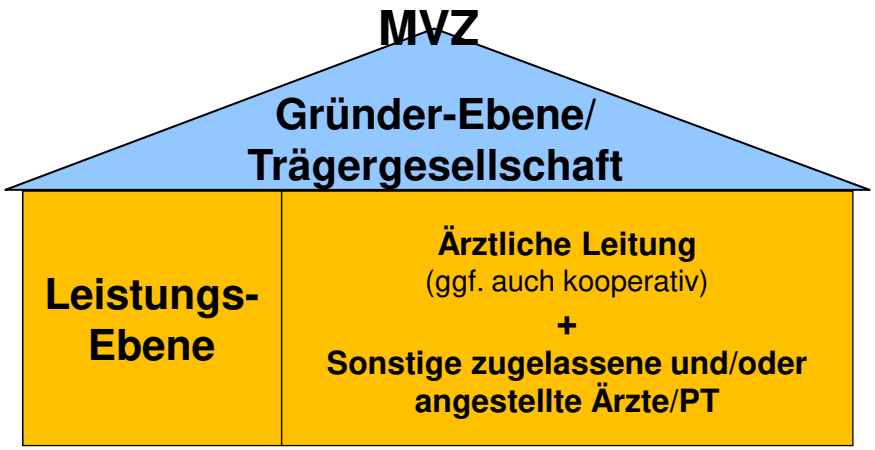
- unterliegt der Bedarfsplanung
- Zulassung durch Zulassungsausschuss
- zulässige Gründer:
  - zugelassene Ärzte/PT
  - zugelassene KH
  - Erbringer nichtärztlicher Dialyseleistungen
  - gemeinnützige Träger (aufgrund Zulassung oder Ermächtigung)
  - Kommunen



Gründereigenschaft zugelassener Ärzte/PT kann auch bei Verzicht auf die Zulassung zum Zwecke der Anstellung im MVZ erhalten bleiben, solange diese im MVZ tätig und Gesellschafter des MVZ bleiben!

- zulässige Rechtsformen bei Gründung:
  - Personengesellschaft (GbR; PartG)
  - eingetragene Genossenschaft
  - GmbH
  - öffentlich-rechtliche Rechtsformen

- fachübergreifend oder fachgleich auf der Leistungsebene; mind. 2 Ärzte mit in der Summe bedarfsplanerischem Anrechnungsfaktor (AF) 1,0
- ärztlich geleitet durch im MVZ tätigen VA (mind. Teilzulassung) oder angest. Arzt (mind. 20 Wo.Std.)
- Bestandsschutz bezügl. Gründer u. Rechtsformen für Alt-MVZ vor dem 01.01.2012



Vertragsarztrechtliche Bestimmungen für Ärzte/Psychotherapeuten gelten auch für die Medizinischen Versorgungszentren entsprechend!

Fotos: Getty Images

Exkurs: Alterseinkünftegesetz

Vorüberlegungen bei der Praxisabgabe

Reicht mein nach der Praxisabgabe verfügbares Einkommen für den gesicherten Ruhestand?

- **Gebildete Rücklagen für das Alter?**
- **Erwarteter Verkaufserlös aus der Praxis?**
- **Alterseinkünfte:**
  seit 2005 werden die Renten aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen nicht mehr mit dem Ertragsanteil, sondern je nach Jahr des Rentenbeginns mit z.B. 64% (2012), 66% (2013), 68% (2014), 70% (2015) oder 72% (2016) besteuert; d.h. deutlich höher als zuvor!



Gefahr: Verfügbares und kalkuliertes Einkommen klaffen ggf. auseinander!

Fazit: Verfügbares Einkommen sollte vor Abgabe berechnet werden!

KVB
Kassenärztliche
Vereinigung
Bayerns

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

